



ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESC VI



OBJETIVOS:

1. Discutir a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (acessibilidade e integralidade do cuidado).
2. Conhecer o perfil de morbimortalidade relacionado à saúde do homem.
3. Conhecer as estratégias de atuação para efetivação da PNAISH na APS.

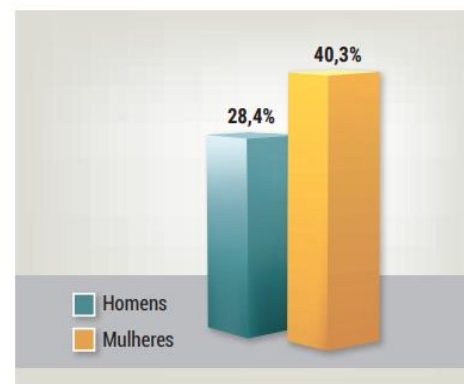
- Embora seja alvo da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), lançada pelo Ministério da Saúde em 2009, a saúde masculina continua um tema desafiador para gestores e profissionais de saúde, que muitas vezes tomam os homens como uma população “rebelde” e destinam a eles apenas ações pontuais e focadas na próstata.



- É recente o olhar sobre a saúde dos homens, reconhecendo-os para além de “contaminadores” e “violadores”, e trazendo-os como sujeitos e objetos do cuidado a partir de suas vulnerabilidades como homens diversos.
- Os homens, mesmo sendo uma população que apresenta os piores indicadores de morbimortalidade, geralmente não possuem o hábito de procurar os serviços de saúde para realizar atividades de prevenção e de autocuidado.



Gráfico 2 - Relação de procura por atendimento para prevenção e realização de exames de rotina entre homens e mulheres



POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS HOMENS

- A PNAISH foi criada em 2009, visando aos indivíduos entre 20 e 59 anos.
- Traz como objetivo principal: “facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da Rede SUS, mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade, da mortalidade e a melhoria das condições de saúde”.



Objetivos específicos:

1. “Organizar, implantar, qualificar e humanizar, em todo território brasileiro, a atenção integral a saúde do homem, dentro dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde”.
2. “Estimular a implantação e implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde”.
3. “Ampliar, através da educação, o acesso dos homens às informações sobre as medidas preventivas contra os agravos e enfermidades que os atingem”.



- A política destaca também a cidadania e o autocuidado, dois aspectos essenciais que têm sido negligenciados na discussão sobre a qualidade de vida dos homens brasileiros.
- Entre os principais objetivos da PNAISH, assinalou-se a necessidade de reconhecer os diversos contextos socioculturais e político-econômicos para a compreensão da realidade singular masculina na promoção de ações de saúde.
- Essa complexa tarefa está esquematizada em cinco eixos:
 - ❑ Acesso e acolhimento;
 - ❑ Saúde sexual e reprodutiva;
 - ❑ Paternidade e cuidado;
 - ❑ Doenças prevalentes na população masculina e;
 - ❑ Prevenção de violências e de acidentes.



POR QUE ATENTAR À SAÚDE DOS HOMENS
NO BRASIL?

- Segundo o banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) os homens brasileiros morrem em média cerca de 7 anos mais cedo do que as mulheres.
- As políticas de saúde brasileiras historicamente privilegiaram mulheres e crianças, e os homens são frequentemente vistos como meros facilitadores ou dificultadores da saúde sexual e reprodutiva feminina.
- É histórico o desconhecimento sobre as peculiaridades de ser homem na sociedade.
- Boa parte de sua mortalidade é por causas evitáveis, muito relacionadas a comportamentos adotados por corresponderem a um estereótipo tradicional de masculinidade.
- Sua inclusão nos serviços de saúde tem ocorrido de uma forma medicalizada e potencialmente iatrogênica, focada no tratamento da disfunção erétil e no rastreamento do câncer de próstata.



ÓTICA DE GÊNERO

- Gênero se refere “[...] aos atributos, papéis ou funções sociais culturalmente legitimados para indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, estabelecendo-os com determinados valores sociais diferentes e desiguais entre si”.
- Essa categoria de análise pretende superar a diferenciação entre homens e mulheres baseada apenas em suas características biológicas e se fundamenta pelas marcas do socialmente construído, do caráter relacional e da dimensão de poder.
- Courtenay observou que os homens construíram sua masculinidade apoiada na crença da invulnerabilidade, o que repercute no seu envolvimento com práticas de risco à saúde tanto no trabalho como no lazer.

- Em compensação, buscam legitimar seu poder e até sua superioridade perante outros homens e outras mulheres.
- Esse modelo de masculinidade foi denominado masculinidade hegemônica e se expressa por seu comportamento e sua atitude diante do risco e por uma sexualidade instintiva, incontrollável, que vem sendo criticado em sua aplicabilidade e ressonância nos dias atuais.
- A compreensão do que significa ser homem auxilia a compreender seu modo de agir e de pensar, a forma como lidam com riscos muitas vezes desnecessários e, o mais importante, promove o estudo de propostas de abordagens mais adequadas do que as que ainda se utilizam.

- Nesse sentido, é preciso considerar o que foi bem proposto por Doyal acerca das “[...] dificuldades psicológicas que eles trazem para as consultas e os desafios que a doença pode colocar para seu senso de identidade”.
- Além da perspectiva de gênero, é importante considerar outras categorias de análise e determinantes sociais da saúde, como raça/cor, renda e estágios do ciclo de vida individual e familiar no entendimento de sua condição de saúde e relação com os serviços e na busca por uma atenção à saúde inclusiva, empática e resolutiva.

PERFIL DE MORBIDADE

- De acordo com estimativas do IBGE para 2017, a população-alvo da PNAISH (homens entre 20 e 59 anos) era de aproximadamente 58,4 milhões, correspondendo a 28,16% da população brasileira.
- Os dados relativos à internação revelam que, à época do lançamento da PNAISH, os homens respondiam por 40% de todas as hospitalizações, sendo a faixa etária-alvo (25-59 anos) 15% do total.
- As causas externas lideravam os motivos de internação com 16%, a maioria relacionada a quedas, seguida por acidentes de trânsito; o grupo populacional mais afetado se encontrava entre 20 e 29 anos de idade.

- Seguindo as causas de internação têm-se as patologias do aparelho circulatório, lideradas pelos acidentes coronarianos (40% das internações) e hipertensão arterial sistêmica (19%).
- O perfil de morbidade masculina também indica a necessidade de estabelecer estratégias em relação ao tabagismo e ao abuso de álcool, fatores de grande impacto no adoecimento dessa população.
- A Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2013 apontou que 19,2% dos homens maiores de 18 anos usa algum produto derivado do tabaco e 21,6% faziam uso abusivo de álcool (entre as mulheres, esses índices são de 11,2 e 6,6%, respectivamente).

PERFIL DE MORTALIDADE

Tabela 87.1 | Principais causas de mortalidade masculina no Brasil conforme capítulo da CID-10 (2015)

Capítulo CID-10	Óbitos
IX. Doenças do aparelho circulatório	182.555
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	124.839
II. Neoplasias (tumores)	111.100
X. Doenças do aparelho respiratório	76.284
Subtotal	494.778

- As causas externas se mantêm como primeira causa de morte entre os adultos jovens, vindo a ser superadas pelas doenças do aparelho circulatório e pelos tumores a partir dos 50 anos – o que é esperado pela história natural desses agravos associados aos efeitos cumulativos dos hábitos de vida.
- A maioria daqueles óbitos é causada por agressões, seguidas pelos acidentes associados ao transporte e a lesões autoprovocadas (suicídios).
- White e Holmes ³⁷ estudaram as taxas de mortalidade em 44 países de diversos níveis de desenvolvimento, incluindo o Brasil, e em todos foi encontrado um excesso de mortes entre os homens devido a causas potencialmente evitáveis, em maior ou menor grau atribuíveis a estilo de vida e a atividades arriscadas.

- As neoplasias que mais matam homens no Brasil são as de traqueia, brônquio ou pulmões, seguidos das de próstata e de estômago.
- Em relação às doenças do aparelho digestório, destacam-se as doenças do fígado, responsáveis pela maior parte das mortes entre homens de 25 a 59 anos e, em boa parte, relacionadas à doença alcoólica.

- Diante desse quadro, qual tem sido o papel dos médicos ao abordar os homens?
- Eles têm reforçado estereótipos ou atentado e problematizado com eles suas circunstâncias de vida, seus hábitos, seus estágios nos ciclos de vida individual e familiar?
- Ao considerar a grande mortalidade por acidentes e violências, não é instigante perceber que muitos homens lidam com esses riscos de uma forma inconsequente, impulsiva, irresponsável?
- Como os homens lidam com sua vulnerabilidade?
- Antes ainda: eles a percebem?



ACESSO E USO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

- O acesso aos serviços, na atenção primária à saúde (APS) envolve a percepção de necessidade de cuidado, a conversão desta em demanda e o comparecimento dos homens ao serviço de saúde.
- Esse processo é assistido por profissionais assoberbados pelas diversas demandas, prioridades, urgências, programas e metas de produção.



BARREIRAS SOCIOCULTURAIS

- O estereótipo do homem invulnerável já foi descrito por vários pesquisadores, em oposição à fraqueza denunciada pela procura ao serviço de saúde, que o aproximaria da representação ainda prevalente da mulher como pessoa frágil.
- Os homens, em geral, não contam com uma adequada rede de apoio, e quando a possuem, têm dificuldade de acioná-la, quando necessário.
- Nesse sentido, prevalece a dicotomia da unidade de saúde como um espaço feminino (não só pela maioria de profissionais mulheres, como também por sua decoração frequentemente feminilizada ou infantilizada), ao passo que o bar é refúgio de socialização masculina.

BARREIRAS INSTITUCIONAIS

- Como se abordam os homens no dia a dia? Tentando adequá-los a programas pré-definidos, comumente focados na próstata e, quando muito, na hipertensão arterial e diabetes?
- Agindo de forma autoritária (“tem de fazer essa dieta, porque não haverá melhora”) ou culpabilizadora (“bebeu desse jeito a vida inteira, agora vamos lidar com as consequências”)?
- Quanto à inadequação dos serviços de saúde, percebe-se que a forma de comunicação com os homens ainda é pobre ou desconsidera suas peculiaridades dentro de uma perspectiva de gênero.
- É preciso considerar que muitos homens comparecem aos serviços de saúde em busca de check-up, ou com queixas vagas ocultam outros problemas ou preocupações.

POSSÍVEIS INADEQUAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

- O senso comum indica que o horário de funcionamento das unidades de saúde pode colidir com o horário de trabalho dos homens, o que justificaria a sua ausência.
- Cabe aos médicos e à equipe refletirem se os homens conseguem ajuda quando precisam, ou se o serviço tenta adequá-los a uma rotina imutável.
- Couto e cols. demonstraram que os homens não são ausentes, mas sim invisíveis nos serviços de saúde.
 - ❑ Os homens estão presentes, mas não percebidos pelos profissionais; não são considerados como sujeitos do cuidado de si ou de terceiros; e não são (ou eram) considerados um destino de políticas públicas.
- Adicionalmente, homens homossexuais, bissexuais e transexuais/transgênero podem evitar o serviço por medo de preconceito por parte dos profissionais.

ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO

- A aproximação com os homens exige mudanças na atitude e nas ações do serviço.
- Figueiredo descreve a experiência em um centro de saúde onde se realizaram tanto atividades em sala de espera quanto atividades extramuros, em que a equipe se aproxima dos locais da comunidade onde os homens estão.
- Eles podem incluir bares, padarias, oficinas mecânicas, canteiros de obras.
- Além da promoção de grupos de homens, sugere-se a participação em eventos já existentes.



```
graph TD; Q((Como adequar o atendimento às demandas dos homens?)) --- A[Entender a saúde do homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, executado nos diferentes níveis de atenção. Deve-se priorizar a AB, com foco na ESF, porta de entrada do sistema de saúde integral, hierarquizado e regionalizado.]; Q --- B[Incluir na Educação Permanente dos trabalhadores do SUS, temas ligados a atenção integral à saúde do homem.]; Q --- C[Reorganizar as ações de saúde, por meio de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços de saúde reconheçam os homens como sujeitos de cuidados.]; Q --- D[Nortear a prática de saúde pela humanização e a qualidade da assistência a ser prestada, princípios que devem permear todas as ações.];
```

Entender a saúde do homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, executado nos diferentes níveis de atenção. Deve-se priorizar a AB, com foco na ESF, porta de entrada do sistema de saúde integral, hierarquizado e regionalizado.

Incluir na Educação Permanente dos trabalhadores do SUS, temas ligados a atenção integral à saúde do homem.

Como adequar o atendimento às demandas dos homens?

Reorganizar as ações de saúde, por meio de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços de saúde reconheçam os homens como sujeitos de cuidados.

Nortear a prática de saúde pela humanização e a qualidade da assistência a ser prestada, princípios que devem permear todas as ações.

- Diante das nuances e determinantes descritos em relação à saúde e ao autocuidado dos homens, gestores e profissionais de saúde, em geral, precisam desvencilhar-se de estereótipos.
- É necessário que se produzam novas abordagens para essa metade da população, melhorando, assim, os indicadores de saúde, reduzindo significativamente as causas evitáveis de morbimortalidade e tornando o sistema de saúde ainda mais universal e integral.



Referências Bibliográficas

DANTAS, G.C.; MODESTO A.A.D. Saúde do homem. In: GUSSO, Gustavo; LOPES, José M.C.; DIAS, Lêda C. (Orgs.). **Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática**. Porto Alegre: ARTMED, 2019, p. 2388. Cap. 87.

COELHO, Elza Berger Salema. *et al.* Política nacional de atenção integral à saúde do homem [recurso eletrônico]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2018. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_integral_saude_homem.pdf



"Se você trata uma doença,
você pode ganhar ou perder.

Se você trata um paciente,
eu tenho certeza que você
sempre irá ganhar, não
importa o desfecho."

Patch Adams



Obrigada!